

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074267-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: ATILA MARTINS PENA

RECORRENTE: MARIA ROSARIO DE FATIMA MARTINS DE MOURA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. UNIÃO. OXIGENOTERAPIA. PARECER DO NAT.. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5074267-43.2024.4.02.5101

510014753855 .V9

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074267-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: ATILA MARTINS PENA

RECORRENTE: MARIA ROSARIO DE FATIMA MARTINS DE MOURA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual **MARIA ROSARIO DE FATIMA MARTINS DE MOURA**, na pessoa de seu representante legal, ATILA MARTINS PENA, objetiva atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão (Evento 3, DESPADEC1), prolatada no âmbito do processo originário de nº 5071488-18.2024.4.02.5101, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia o fornecimento do insumo, "OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA (ODP)", sob a alegação de doença grave ("Fibrose Pulmonar Idiopática - insuficiência respiratória crônica [...] associado a dispneia").

Em evento 17 consta parecer do NAT.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 19, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão, verbis: (processo nº 50714881820244025101, evento 3, DESPADEC1).

A autora requer concessão da tutela provisória de urgência, para que os réus forneçam os insumos para OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, com CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (duas modalidades estacionárias, sendo uma não dependente de energia elétrica, e mais uma modalidade portátil de fornecimento de oxigênio), para uso contínuo a 2 litros/min em cateter nasal tipo "óculos", pelo tempo que se fizer necessário.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Intime-se e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias, devendo ainda carrear aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, cumprindo assim a norma do art. 11 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Manifeste-se também, na mesma oportunidade, quanto à caracterização de litispendência ou coisa julgada de que tenha conhecimento.

Ainda, diante dos princípios contidos no art. 2º da Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995, subsidiariamente aplicada (art. 1º da Lei nº 10.259/2001), notadamente os princípios da celeridade e da economia processual, a parte ré, no mesmo prazo, apresentará proposta de transação por escrito, se for do seu interesse, o que não significará nenhuma admissão de culpa nem será levado em consideração num possível julgamento de mérito. Havendo proposta, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, vindo os autos imediatamente conclusos para homologação do acordo, se for o caso.

Venham conclusos para sentença de mérito ou terminativa, não havendo proposta de acordo".

É o breve relatório.

Pois bem, sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

No caso, a parte autora comprovou todos os requisitos.

O parecer do NAT informou que o tratamento de oxigenoterapia domiciliar e seus equipamentos estão indicados diante da condição clínica que acomete a parte autora.

órgãos centrais decorrente da melhora na capacidade do exercício com o uso de oxigênio contínuo dura. Leitor de PDF: melhor explicação para a obtenção destes benefícios".

Assim, informa-se que a **oxigenoterapia domiciliar** (concentradores de oxigênio modalidades estacionária e portátil, sendo uma não dependente de energia elétrica e máscara nasal tipo óculos) **está indicada** ao manejo da condição clínica da Autora – Fibrose Pulmonar Idiopática relacionada à colagenose (artrite reumatoide), apresentando insuficiência respiratória crônica com hipoxemia importante em ar ambiente associado a dispneia aos mínimos esforços (Evento 1, ANEXO2, Página 10).

Informa-se que a CONITEC avaliou a incorporação da oxigenoterapia domiciliar, estando recomendada para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)² – o que não se enquadra ao caso da Autora. Assim, a oxigenoterapia é contemplada no SUS de acordo com a Tabela Unificada do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP, na qual consta oxigenoterapia, sob o código de procedimento: 03.01.10.014-4, para área ambulatorial, hospitalar e de atenção domiciliar. No entanto, até o presente momento, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento com oxigenoterapia domiciliar, bem como não foram identificados outros equipamentos que possam configurar alternativa.

Considerando que é de responsabilidade do médico determinar a necessidade e a forma de administração do oxigênio, caso haja a aquisição dos equipamentos de oxigenoterapia domiciliar pleiteados, a Autora deverá ser acompanhada por médico especialista, a fim de que sejam realizadas orientações e adaptações acerca da utilização dos referidos equipamentos, bem como reavaliações clínicas periódicas. Neste sentido, informa-se que a Autora está sendo assistida pelo Instituto de Doenças do Tórax IDT/UFRJ (Evento 1, ANEXO2, Página 10), que poderá promover o seu acompanhamento.

Elucida-se que insumos para oxigenoterapia domiciliar possuem registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob diversas marcas comerciais.

Aduziu que, embora o tratamento seja coberto pelo SUS, a incorporação foi feita apenas para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o que não se enquadra no quadro clínico da parte autora.

Esclareceu que até o momento não foi localizada nenhuma forma de acesso pela via administrativa ao tratamento de oxigenoterapia domiciliar e que não foram identificados outros equipamentos que possam configurar uma alternativa terapêutica.

Em relação à incapacidade financeira de custear o medicamento/suplemento, entendo que a mesma restou comprovada, na medida em que a parte autora está representada pela Defensoria Pública.

De tal sorte, comprovada a impossibilidade de arcar com os custos da medicação/insumo, a essencialidade, a urgência e a impossibilidade de substituição dos medicamentos/insumos por qualquer outra alternativa terapêutica, resta configurado o dever das rés quanto ao fornecimento do insumo/fármaco/aparelho à parte autora.

Ainda, no que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispõe: "ENUNCIADO 40 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que o tratamento médico seja fornecido à parte autora.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

*Por essas razões, **defiro o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo ativo**, determinando-se que os réus, solidariamente, providenciem à parte autora/recorrente o tratamento de **Oxigenoterapia Domiciliar**, com concentradores de oxigênio (nos termos do laudo médico), para uso contínuo, pelo tempo que se fizer necessário, no prazo de 10 dias. Intimem-se."*

Logo, a decisão liminar, que atribui o efeito suspensivo ativo ao recurso, observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais devendo, dessa maneira, ser ratificada.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER** e **DAR PROVIMENTO** ao recurso. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado.